

Histerectomía vaginal (por prolapso)

Información para el paciente · Extirpar el útero a través de la vagina, con una elevación de la parte superior de la vagina

WARWIKI

Cuando el útero ha descendido como parte de un prolapso de órganos pélvicos, una opción es la **histerectomía vaginal** — extirpar el útero por completo a través de la vagina, **sin incisión abdominal**. Casi siempre se combina con una **suspensión** de la parte superior de la vagina (y a menudo otras reparaciones) para que la zona quede bien sostenida después.

Acerca de este procedimiento

El útero se separa y se extrae a través de la vagina. Luego se **suspende la parte superior de la vagina** a sus propios ligamentos pélvicos fuertes para que no vuelva a prolapsarse más adelante. Según su examen, se pueden añadir reparaciones de la pared frontal o posterior. La vía vaginal generalmente significa **menos dolor y una recuperación más rápida** que la cirugía a través del abdomen.

Cosas que debe saber

- Extirpar el útero pone fin a la menstruación y a la capacidad de llevar un embarazo.
- Si el prolapso afecta principalmente al útero y usted desea **conservar su útero**, una suspensión que conserva el útero (histeropexia) puede ser una opción — pregunte a su cirujano.
- Si es necesario, se puede añadir un procedimiento aparte para el **escape de orina**.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Histerectomía

Cirugía para extirpar el útero.

Vía vaginal

Se hace a través de la vagina, sin incisión abdominal.

Suspensión de la cúpula

Reanclar la parte superior de la vagina para que siga sostenida.

Histeropexia

Una alternativa que conserva el útero y lo suspende sin extirparlo.

Prolapso

Cuando los órganos pélvicos descienden y causan un bulto o presión.

Taponamiento vaginal

Gasa colocada brevemente después de la cirugía para apoyar la cicatrización.

¿LE DOLERÁ? Se hace bajo anestesia, así que usted no siente nada durante el procedimiento. Como no hay incisión abdominal, la recuperación suele ser más fácil que con otras vías de histerectomía — espere molestias de leves a moderadas, y la mayoría de las personas regresa a casa el mismo día o después de una noche.

Cómo prepararse

- Siga sus **instrucciones de anestesia** (ayuno, suspenda los anticoagulantes según le indiquen).
- Una evaluación preoperatoria; converse si se añadirán otras reparaciones o un procedimiento contra el escape.
- No fume; organice quien lo lleve y ayude en casa.

Qué sucede

- 1 Usted está bajo anestesia; se administran antibióticos.
- 2 El útero se separa y se extrae **a través de la vagina**.
- 3 La parte superior de la vagina se **suspende** a sus ligamentos; las reparaciones añadidas se hacen según lo planeado.
- 4 Se colocan brevemente una sonda y a veces un taponamiento vaginal.

Después de la cirugía

- Es normal tener un ligero manchado o flujo durante algunas semanas mientras cicatriza la parte superior de la vagina.
- **Evite levantar peso, hacer esfuerzo y las relaciones sexuales durante unas 6 semanas.**
- Mantenga las heces blandas para evitar el esfuerzo; descanse y luego aumente la actividad poco a poco.

Llame a su equipo de atención si tiene:

- Fiebre o escalofríos, o sangrado abundante
- **No puede orinar**, o dolor pélvico/abdominal que empeora
- Flujo con mal olor, o algo que sale a través de la vagina

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La histerectomía vaginal extirpa el útero a través de la vagina (sin incisión abdominal) e incluye una suspensión de la parte superior de la vagina.
2. Pone fin a la menstruación y al embarazo; si desea conservar su útero, pregunte por una suspensión que conserva el útero.
3. Evite levantar peso y las relaciones sexuales por unas 6 semanas; el manchado es normal. Llame si tiene fiebre, sangrado abundante o problemas para orinar.